照顧一位重症肌無力病人之護理經驗

洪鈺珺[1]　陳惠美[2*]　黃美玲[3]

本文描述一位重症肌無力再復發個案，因四肢無力、吞嚥困難等症狀，對於預後未知性及生活質量等因素，表達不安之護理經驗。於2022年3月1日至2022年3月9日藉由身體評估、觀察、會談、傾聽、實際照護、病歷查閱方式收集資料，運用Gordon 11項功能性健康評估，確立個案有身體活動功能障礙、吞嚥困難及焦慮等健康問題。藉由透過跨團隊的合作模式，安排個別性日程復健計畫，讓個案早日恢復日常生活自理；提供重症肌無力病友會資訊，協助個案於出院後獲得自我歸屬感，學習與疾病共存。單位也製作重症肌無力的影片衛教及電訪追蹤，讓後續更多肌無力患者，增進對於疾病認知及早適應疾病，回歸正常生活方向，期望藉此經驗分享，以提供日後護理人員照護之護理參考。

關鍵詞：重症肌無力、身體活動功能障礙、吞嚥困難、焦慮

[1]國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院護理部護理師　[2]國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院護理部護理長
[3]國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院護理部副主任
[*]通訊作者姓名／地址：陳惠美　雲林縣斗六市雲林路二段579號
電話：（05）532-3911 分機 567326　　電子信箱：Y02267@ms1.ylh.gov.tw

DOI: 10.6740/NTUHJN.202501_21(1).0005



前 言

目前台灣發生率為每十萬分之2.2人，盛行率為每十萬分之23.2人，大約每十萬人就有2位病例的發生率，每百萬人就有14位病例的盛行率，且其中以65歲以上到79歲間老年族群發生率最高，所有年齡皆會罹病，男女發生率約為2比3（羅等，2020；衛生福利部，2021）。重症肌無力是一種自體免疫疾病，主因為乙醯膽鹼受體數目減少，臨床上常見症狀為肌肉無力，如:眼瞼下垂、四肢無力，進而導致身體活動功能障礙，部分有吞嚥障礙，衍生吸入性肺炎、呼吸衰竭最終導致死亡，故早期診斷及早治療，可減少後遺症發生（楊舒媚等，2021）。

本文描述照護一位重症肌無力再復發病人之護理經驗，因疾病導致身體活動功能障礙、吞嚥困難及焦慮，護理期間因個案對疾病的再復發，導致日常生活無法自理其餘之困擾，害怕造成父母負擔，對於疾病的預後產生不安，未來的生活型態產生莫大恐懼，延伸出個案焦慮、不安等情緒反應，而引發探討動機，藉由提供個別及獨特性的護理，解決身心方面問題，使個案保持正向態度面對治療，期望能達到提供完整性照護之目的，讓個案可勇敢面對返家照護。

文獻查證

一、簡介重症肌無力

重症肌無力主因為乙醯膽鹼受體數目減少，導致神經肌肉傳導接收障礙，常見症狀為肌肉無力，如：眼瞼下垂、吞嚥困難、四肢無力，進而導致身體活動功能障礙，臨床上肌肉會在活動時逐漸無力，而休息後便能恢復，因情緒起伏及其餘疾病等影響，即便病人有規律服藥，仍導致疾病有惡化可能性，藥物治療：抗乙膽鹼酯酶抑制劑，藥物為pyridostigmine，當症狀無法以pyridostigmine有效控制時，改使用慢性免疫抑制治療，皮質類固醇是免疫調節療法優先藥物為prednisolone，合併azathioprine使用，能有效恢復與減少類固醇的副作用，而臨床發生重症肌無力危象時，快速免疫調節治療：血漿置換術：適用重症肌無力危症患者或症狀嚴重的病人、注射免疫球蛋白：研究顯示可改善70%全身肌無力之症狀；手術治療：胸腺切除等治療方式（賴，2014；羅等，2020；楊舒媚等，2021）。

二、重症肌無力障礙對病人身體功能之影響

身體活動功能障礙是指個人獨立活動情形受限的狀態，因受損部位不同而影響身體活動力，甚至失去獨立自我照顧能力，可藉由復健治療來協助病人達成獨立肢體活動，增進自我日常生活獨立性（賴，2014; Yew & Cheng, 2015）。在肢體無力期間協助適當的擺位，避免關節萎縮，維持身體姿勢及位置，教導關節運動並預防核心肌肉變形，上肢的訓練在遠端無力者，可教導復健球，練習抓握；近端無力者，可執行手臂的揮動等步驟，下肢部分教導漸進式活動，由坐到

站，利用床上腳踏車運動達到下肢肌力訓練，建議每週至少進行150分鐘的運動，也可運用輔具來協助生活自理能力，並衛教正確的行走姿勢，適時正向鼓勵及建立信心，運用跨團隊照護，復健師專業指導，進行自我復健訓練，達到日常生活獨立性（楊嘉豪，2016；Gilhus, 2021）。

二、重症肌無力對吞嚥影響之護理

重症肌無力的吞嚥困難相較於中風及帕金森的病人，及早藥物治療後，吞嚥障礙能有效緩解（楊舒媚等，2021），臨床上護理師為第一線接觸人員，可給予喝水吞嚥評估試驗，用於確認病人是否有吞嚥障礙，先以3 mL開水做測試，若無嗆咳，才可再執行100 mL水量，若過程中明顯嗆咳，診斷為吞嚥障礙（吳等，2015），護理措施包括增稠劑使用，它能減緩水流速，達成口咽內安全吞嚥反應，臨床上也能將水、茶、果汁搭配使用，讓營養達成均衡。教導正確的吞嚥訓練方式：（一）用力吞嚥法、（二）超上聲門吞嚥法（super-supraglottic swallow）、（三）下巴內縮法。飲食建議少量多餐，因用餐時間的加長，易有口腔肌肉疲勞無力，食物質地上可選擇更省力的方式，將食物變成較小的碎片或偏軟的食物，漸進式調整成飲食，並衛教照顧者及病人返家後飲食注意事項，避免過度的吞嚥肌力訓練，以免加重肌肉的無力（林等，2020；鄭、陳，2020；楊舒媚等，2021）。

三、心理層面照護之方法

多數重症肌無力病人因長期受症狀干擾，擔心疾病進展無法治癒，會出現心理不安、焦慮等的心理問題，因疾病普及度不高，易與親友溝通時的障礙產生，後續疾病復發的治療時，有溝通問題的壓力產生，進而導致病人產生焦慮的情緒（莊、葉，2024）。使用貝克焦慮量表，測量焦慮嚴重程度，極輕度為0-7分、輕度8-15分、中度16-25分、嚴重焦慮26-63分（車等，2006），給予陪伴、傾聽了解內心感受，以低頻率、緩慢說話的方式減輕病人的緊張，在完成各項復健活動後，透過眼神凝視、臉部表情及語言鼓舞，重建病人自信心，達到良好護病關係（楊荊生，2014），非藥物的方式，例如：音樂治療：選擇以輕慢板、音頻不超過60分貝的選擇、薰衣草精油：可增進副交感的活性，以利放鬆的成效、芳香療法：能穩定心靈且有安撫心理的效益、宗教信仰：從閱讀佛經中，消除心中雜念，轉化焦躁不安的心態，以上方式學習心態改變，後續出院提供重症肌無力病友會，讓病人和親友有協同效應能互為鼓勵，因而減輕疾病的焦慮感（程等，2014；李等，2015；陳等，2016；葉、王，2024；莊、葉，2024）。

個案簡介

一、基本資料

李先生，42歲，專科畢業，慣用國、台



語，未婚，2019年10月診斷出重症肌無力，因疾病因素需常跑醫院回診及身體負荷問題，故將保全工作辭職，平時採用低劑量Prednisolone藥物，肌肉無力症狀已改善，可日常生活自理，目前在小公司上班，辦理行政工作，生活規律，兩個姊姊都已出嫁，目前和父母同住，主要經濟來源為工作薪資，父母皆為公務人員，經濟狀況小康，住院期間主要照顧者為案母，醫療決策者主要為個案本身，決策前會先與父母共同討論。

二、入院及住院治療經過

家族無慢性遺傳性疾病及自體免疫病史。於2022/3/1因手腳無力、喝水有嗆咳情形，故到本院急診就醫，GCS：E4V5M6，四肢肌力評估皆為3分，平時採用低劑量Prednisolone 2PC PO BID藥物控制，照會神經內科表示重症肌無力急性期建議施打免疫球蛋白（IVIG）治療並調整口服用藥，故住院治療，於3/2-3/7施打5日IVIG，施打期間肌力、吞嚥狀況有顯著進步，搭配復健治療計畫進行，於3/11可出院返家。

護理評估

護理期間為2022/3/1至3/11經由直接照護、實際觀察、病歷紀錄瀏覽、家庭會議、出院準備服務等Gordon 11項功能性健康型態評估工具過程收集資料，針對個案、主要照顧者、家庭系統及社會資源等進行整體性護理評估。

一、健康認知和健康處理型態

此次住院前會跟朋友去爬山，個案自覺養成良好的運動習慣可讓身體變健康，無不良嗜好，定期回門診追蹤及規則服藥，3/1個案主訴：「都有按時回診及服藥，怎麼這次又突然手腳沒有力氣，也沒辦法走路，要怎麼辦才好？」、「這次回家也不知道能不能再次去爬山」，3/2個案主訴：「這次手腳變無力，我很害怕，不知道會不會變的更嚴重，以後要靠別人幫忙，我不想這樣」、「治療後肌肉力量不知道會不會恢復到原來的樣子，我很怕我無法走路，變殘廢了」，住院期間可積極配合服藥與接受各項醫療處置。

二、營養與代謝型態

身高165 cm，體重58.3 kg，身體質量指數為21.4 kg/m^{2}屬正常範圍，住院前三餐皆由媽媽準備，平時進食8分滿的飯量，飲食清淡，不挑食。3/1評估吞嚥測試喝水100 mL出現嗆咳反應，搖頭表示不要喝水，故評估吞嚥測試：第三階段不通過，住院間由口進食，三餐皆訂院內吞嚥困難餐：剁碎及軟嫩的食材，依照需求增加增稠劑來改變食物質地，熱量1800大卡／天，進食速度慢，3/1個案主訴：「我這兩日喝水，總覺得喉嚨卡卡的，所以這幾天我都不太敢喝水」、「我不會以後都不能正常吃東西了吧！我這情形住院後會改善嗎？」，3/2執行螢光錄影吞嚥檢查，結果顯示咽喉期的吞嚥障礙，吃午餐時，吃完一口後，口中留有食物殘

渣，3/2案母主訴：「那我可以準備甚麼食物給他吃？」，靜脈滴注生理食鹽水1,500 mL/day，口腔黏膜完整，全口無缺牙，四肢及軀幹皮膚飽滿，無水腫及無乾燥或壓傷情形，指甲床及唇色粉紅，微血管充填<3秒，3/11 Hb：14 g/dL，Albumin：3.1 g/dL。

三、排瀉型態

住院前解尿約每日6-7次，尿液清澈淡黃色，排便每日一次，呈黃軟便。住院期間每日可自解尿液約1,500-2,000 mL，呈黃色清澈無沉澱物，無排尿困難及灼熱感情形，但因行動受限，尿壺使用，視診腹部平坦、聽診腸蠕動音20-25次／分鐘，每日可排便1次、呈黃色軟便、量中，腹部柔軟，無腹脹。

四、活動與運動型態

此次生病前除了定期爬山的習慣，偶爾會和父母親一起散步運動，約30分鐘。3/1巴氏量表評估活動功能：需協助進食、盥洗、沐浴、穿衣褲、如廁、上下床及轉位、上下樓梯及大小便需協助，評估ADL 55分為重度依賴。床上活動需案母協助，體溫：36.5度，心跳：78次／分鐘，呼吸：18次／分鐘，血壓：126/56 mmHg，3/1個案主訴：「活動都需要別人的幫忙，這是第二次了，我很害怕，也擔心爸媽會被我拖累」，3/2個案主訴：「現在無法走路至浴廁，大小便及洗澡都必須在床上，需要媽媽協助，對媽媽真不好意思」、「不知道復健後會不會像之前一樣好起來，我很擔心」，無法獨立完成轉位動作，需協助使用輪椅下床活動，個案表情失落，出現退縮及被動行為。3/2-7施打IVIG後，3/6個案主訴：「我現在覺得比較有力氣」、「復健加藥物治療下有成效，對自己更有信心」，評估個案可執行轉位，並可以在床邊練習站立，使用助行器可短距離到門口，評估ADL 70分為中度依賴，個案表情有笑容，對於下午的復健內容，更主動配合復健。

五、睡眠與休息型態

住院前每天晚上約10至11點就寢，早上約6點半起床，無使用安眠藥物。住院期間，因擔心病情，睡眠斷斷續續，3/2個案主訴：「這次又手腳無力，我晚上一直想著這件事情，都沒甚麼睡」，3/3、3/4白天面容顯疲倦，持續打哈欠，偶會閉眼休息。3/6個案主訴：「昨日復健時，覺得肌力有進步，搭配薰衣草精油按摩後，這幾日睡的最好一次」，3/7白天面容精神狀況佳，3/9個案主訴：「現在生活可自理後，睡眠品質回到跟住院前差不多了。

六、認知及感受型態

個案意識清楚，視、聽、嗅、和觸覺皆正常，無疼痛情形。3/1個案主訴：「希望這次會變好，我很怕會越來越嚴重」、「吞嚥也有問題，會不會連吃東西都不能吃，我很擔心增加家人麻煩」，臉部表現出沮喪、無奈情形。

七、自我感受及自我概念型態

此次生病前個性開朗、性情溫和，不易



發脾氣、人際關係良好，自認平時身體健康，自從第一次發病後，特別重視身體保養，3/2案母表示個案情緒較為淡漠、少說話，觀察個案神情落寞，面帶憂愁，3/2個案主訴：「不知道這一次可以恢復到甚麼程度，還是會越來越嚴重，要怎麼辦才好」，3/3個案主訴：「我爸媽為了我付出很多了，這一次又這樣，要怎麼辦」，害怕之後家中長輩年紀漸長，對於疾病的復發感到擔憂。

八、角色與關係型態

個案扮演角色有病人、兒子、弟弟，有兩位出嫁的姊姊，現與父母同住，平時心中有事一定找父母親互相討論。住院期間，案母守在個案身邊寸步不離，照顧的無微不至，案父及兩位姐姐會打電話或使用Line群組視訊關心個案，家庭支持系統良好、感情融洽。

九、性與生殖型態

3/1身體評估時，視診個案生殖器外觀正常，無潰爛或異常分泌物，住院期間表示：「不想耽誤女孩一生，所以不會有結婚打算」，因求佛的因素，本身講究無欲無求。

十、因應及壓力耐受型態

個案自述是一個樂觀、面對問題的人，不會因為困難即逃避。3/2個案表示：「2019年診斷出重症肌無力時，以為我只能躺在醫院一輩子，最後還是正向面對，並接受治療及復健」、「我還會再復發嗎？」，3/3個案主訴：「都有再追蹤治療了，還是又發生，之後會不會都有這樣的狀況發生」，面帶愁容、神情失落，評估貝克焦慮量表23分為中度焦慮。3/9個案主訴：「我現在力氣有進步，有總回到一開始還沒住院前的狀況」。

十一、價值與信念型態

個案信仰佛教，遇到不如意的事也會到佛室拜拜。住院期間案母請家人拿佛教書籍前來醫院，供個案閱讀，閱讀完後個案心中也會平靜許多。

問題確立

綜合以上評估後，個案之健康問題有身體活動障礙、吞嚥功能障礙、營養少於身體所需、焦慮及睡眠型態紊亂，而營養少於身體所需是吞嚥功能障礙引起，睡眠型態紊亂是焦慮所引起，故確立健康問題如下：

一、身體活動功能障礙／與肌無力對身體影響有關（2022/3/1訂）。

二、吞嚥功能障礙／與疾病引發吞嚥肌肉無力有關（2022/3/1訂）。

三、焦慮／與疾病影響心靈層面有關（2022/3/2訂）。

護理計劃與評值

健康問題一、身體活動功能障礙／與肌無力對身體影響有關（2022/3/1~3/11）

<table>
<tr><td>主客觀資料</td><td>S1. 3/1個案：「都有按時回診及服藥，怎麼這次突然手腳沒有力氣，也沒辦法走路，要怎麼辦才好？」。
S2. 3/2個案：「這次手腳變無力，我很害怕，不知道會不會變的更嚴重，以後要靠別人幫忙，我不想這樣」。
S3. 3/2個案：「現在無法走路至浴廁，大小便及洗澡都必須在床上，需要媽媽協助，對媽媽真不好意思」。
S4. 3/6個案主訴：「我現在覺得比較有力氣」。
O1. 3/1 GCS：E4V5M6，四肢肌力評估皆為3分。
O2. 3/2床上活動無法獨立完成轉位動作，需協助使用輪椅下床活。
O3. 3/2巴氏量表評估活動功能：需協助進食、盥洗、沐浴、穿衣褲、如廁、上下床及轉位、上下樓梯及大小便可控制，評估ADL 55分為重度依賴。
O4. 3/6再次評估巴氏量表評估活動功能，評估ADL 70分為中度依賴。</td></tr>
<tr><td>護理目標</td><td>1. 3/7個案能在自行使用助行器到病房門口。
2. 出院前個案四肢肌力進步至4分。</td></tr>
<tr><td>護理措施</td><td>1. 每班評估個案肌肉力量及肢體活動度並記錄。
2. 3/1教導雙手抓握復健球，練習抓握肌力，雙手每次30下，一日3次。
3. 3/1教導個案充分休息後，執行手臂揮動（雙手保持平直，往下揮動超過90度，再恢復平直的姿勢）肌力活動，雙手各揮動30次，一日3次。
4. 3/2上午提供床上腳踏車進行下肢運動，速度設定為2，依照個案可負荷程度逐漸增加，每日3次。
5. 3/2上午教導下肢肌力運動：躺在床上，一隻腳彎曲，將另一隻腳伸直抬離床面，停留5秒後放下，反覆10次後換另一隻腳，每日3次，身體疲累時可停止復健並休息。
6. 3/3上午與復健團隊討論，與個案、案母、復健師共同擬訂每日復健運動表，安排個案的復健運動：早上10點、下午3點及晚上8點進行復健運動（如下），並告知疲累時可停止復健，勿過度運動。
<table>
<tr><th colspan="2">每日復健行程表</th></tr>
<tr><th>時間</th><th>每天（自覺疲累時，可停止復健）</th></tr>
<tr><td>上午11點</td><td>復健球抓握＋手臂揮動訓練＋床上腳踏車</td></tr>
<tr><td>下午3點</td><td>復健球抓握＋手臂揮動訓練＋床上腳踏車</td></tr>
<tr><td>晚上8點</td><td>復健球抓握＋手臂揮動訓練＋床上腳踏車</td></tr>
</table>
7. 3/4教導及回覆示教個案如何自行坐在床邊：先右側臥，左手抓握床欄，右手撐著床慢慢爬起身，坐在床邊，案母可視情況給予協助。
8. 3/5下午教導床邊站立，坐在床邊後，雙手抓住助行器，緩慢站起身，執行站立動作。
9. 3/6教導及回覆示範便盆椅使用，將便盆平行放置床旁，須將輪子固定，個案坐床邊使用助行器起身，站穩後轉身坐在便盆椅上。
10. 3/6教導及回覆示教個案使用助行器行走：個案坐於床側，助行器放於床旁，雙手扶著握把站起，先將助行器往前移，雙腳再分別向前移動，每日可練習三次，漸進式增加步行距離。
11. 每日給予正向鼓勵，增加自信心：「有進步喔！你做的很棒」。</td></tr>
</table>



護理評值	1. 3/3個案練習抓握練習，並說：「護理師這樣練習，我覺得我的手好像比較有力氣了」。 2. 3/5個案：「使用床上腳踏車訓練後，我覺得腳越來越有力量」。 3. 3/7個案可正確自行使用便盆椅如廁，且能每日完成復健行程表。 4. 3/8個案可使用助行器走到病室外走廊。 5. 3/9評估病人四肢肌力皆4分。 6. 後續追蹤：3/11返家後電訪，個案主訴：「我雖然動作還是沒以前的快速，但我都可以自已慢慢達成，謝謝你們的照護」。 **後續照護計畫：**提供輔具資源中心資料，協助申請所需輔具。

健康問題二、吞嚥功能障礙／與吞嚥肌肉無力、潛在性肺吸入有關（2022/3/1~3/11）

主客觀資料	S1. 3/1個案：「我這兩日喝水，總覺得喉嚨卡卡的，所以這幾天我都不太敢喝水」。 S2. 3/1個案：「我不會以後都不能正常吃東西了吧！我這情形住院後會改善嗎？」。 S3. 3/2案母：「那我可以準備甚麼食物給他吃？」。 O1. 3/1評估吞嚥測試喝水100 mL出現嗆咳，第三階段不通過。 O2. 住院間三餐訂院內吞嚥困難餐，熱量1800大卡／天，進食速度慢。 O3. 3/2執行螢光錄影吞嚥檢查，結果顯示咽喉期的吞嚥障礙，吃午餐時，吃完一口後，口中留有食物殘渣。
護理目標	1. 3/2案母可正確泡製增稠劑。 2. 3/7個案及案母能說出三項飲食注意事項。 3. 住院期間無發生嗆咳而引發肺炎。
護理措施	1. 3/1早上11點運用單位製作之圖卡教導個案及案母食物準備：可使用切碎、打成泥或煮軟之方式，餅乾、麵包或饅頭可泡軟食用及液體食物須使用增稠劑；用物準備方面：淺及窄的湯匙、增稠劑。 2. 3/1下午與語言治療師共同教導個案及案母，增稠劑使用之方式及注意事項：加入一匙增稠劑溶於100 mL茶水、果汁、清湯等液態食物，使用攪拌器攪拌至有稠度後食用。 3. 3/2與營養師共同衛教個案及案母，食物質地準備：將食物變成較小的碎片，選擇質地軟的食物：粥、布丁、木瓜…等，並採少量多餐方式及提供飲食影片增進認知。 4. 3/2運用單位製作口腔照護衛教指導用具，衛教個案及案母口腔清潔重要性及需準備的用具種類、用途：有漱口水、牙膏、牙刷、護唇膏。 5. 3/3運用單位拍攝之進食技巧影片，提供個案及案母觀看，內容有增稠劑使用、進食注意事項、餐具準備。 6. 3/4上午教導吞嚥訓練，（1）用力吞嚥法：嘴為張開，舌頭頂上顎隨即用力吞嚥口水，以訓練咽喉上升之幅度。（2）超上聲門吞嚥法：吸氣後憋氣，憋著狀態下吞嚥口水兩次，咳嗽後再執行一次，建議頻率為一日三次，視情況調整訓練時間，避免過度肌力訓練，以免加重吞嚥肌肉的無力。 7. 3/5上午教導正確的吞嚥姿勢保持「下巴內縮」訓練：吞食物之前深吸氣、吞嚥時閉住氣、吞完後進行咳嗽，以確保清除口中殘物。 8. 3/6給予及衛教個案及案母返家後飲食教育手冊，包含：吃飯時採坐姿進食、不使用吸管喝水，以免嗆咳、使用窄淺湯匙、食物準備、一口進食完後再進食下一口，吞入後有異物感可咳嗽清喉嚨，確認無異物再進食下一口，避免進食過久易肌無力，導致嗆咳發生。 9. 依醫囑施打IVIG共5天，3/2-/7。
護理評值	1. 3/2案母能將增稠劑加入果汁，濃度合宜讓個案少量多次飲用完，無嗆咳情形。 2. 3/5個案進食採坐姿，可將吞嚥困難餐分多次進食完，無嗆咳情形。 3. 3/6個案可自行執行吞嚥訓練一日三次，若當日較為疲倦會自行增減運動次數。 4. 3/7個案及案母可正確說出可食用軟質物品，有布丁、豆腐、蒸蛋，液體的食物須使用增稠劑，食物需切成小碎片；吃飯需坐起，並小口小口吃，使用窄淺湯匙，勿使用吸管及進食時間勿過久。 5. 住院期間飲食無發生嗆咳情形，胸部影像檢查:顯示正常，無肺炎。 **後續照護計畫：**衛教個案及案母出院返家，增稠劑仍需繼續使用，若使用後有嗆咳情形，可打電話至護理站或營養諮詢室詢問及返診時告知醫師。

健康問題三、焦慮／與疾病影響心靈層面有關（2022/3/2~3/8）

主客觀資料	S1. 3/2個案：「這次又手腳無力，我晚上一直想著這件事情，都沒甚麼睡」。 S2. 3/2個案：「不知道這一次可以恢復到甚麼程度，還是會越來越嚴重，要怎麼辦才好」。 S3. 3/2個案：「不知道復健後會不會像之前一樣好起來，我很擔心」。 S4. 3/6個案：「復健加藥物治療下有成效，對自己更有信心」 O1. 3/2觀察到個案無法獨立完成轉位動作，需協助使用輪椅下床活動，個案表情失落，出現退縮及被動行為。 O2. 3/2、3/3白天面容顯疲倦，持續打哈欠，偶會閉眼休息。 O3. 3/2評估貝克焦慮量表23分為中度焦慮。 O4. 3/3面帶愁容、神情失落。 O5. 3/7白天面容精神狀況佳。
護理目標	1. 3/5個案可執行3種緩解焦慮的方法並實際運用。 2. 3/7貝克焦慮量表由中度焦慮降低為輕度焦慮。
護理措施	1. 3/1向個案自我介紹：您好，我是照顧您的護理師，我叫洪〇〇，每天主動問候，告知有任何需要及問題皆可提出，達到信任及安全感，以利增進護病關係。 2. 執行任何治療及復健運動前，告知個案治療目的及過程，並適時詢問個案的想法，減少對於醫療行為的焦慮。 3. 3/2早上10點陪同醫師查房，主動告知其目前病情進展、用藥治療，並給予重症肌無力介紹單張，與個案共同閱讀單張，增加其對疾病的認知，有問題可立即解惑，減少焦慮感。 4. 3/2因案母之前偶爾會失眠，有在使用薰衣草精油助眠，故請案父帶精油至醫院服務台，由案母拿取，下午教導個案及案母使用薰衣草精油進行按摩，將精油滴在手心上，由腳踝處往小腿、小腿往大腿案壓，可幫助肌肉放鬆及減輕焦慮。 5. 3/3當個案出現情緒低落表現時，接受個案情緒上的抒發，輕拭拍肩膀，適時給予讚美，以增加自我價值感。 6. 3/3於個案晚上睡眠前使用薰衣草精油按摩身體，搭配自然深呼吸，讓芳香釋放於空氣中，播放60音貝的輕柔歌曲，達到舒緩身心靈、減輕焦慮、助眠的效果。 7. 3/4因個案信奉佛教，平時研讀佛教書籍，藉此詢問佛教的小故事，個案會解釋典故來源，協助個案轉移注意力。 8. 3/5鼓勵個案在不疲累狀況，可實施復健計畫，增進上、下肢的肌力訓練，利用運動方式增加肌力，可早日實施自我照顧減輕焦慮。 9. 個案復健時，鼓勵家屬在旁陪伴及支持，給予讚美與肯定：「加油！快完成了，你可以的」，提升自我價值感。 10. 住院期間內心理師協助、傾聽心靈輔導，提供返家重症肌無力病友會，讓個案出院後有同伴及認同感，並相互支持鼓勵共同的目標。
護理評值	1. 3/3下午案母會使用精油按摩個案手腳。 2. 3/4個案表示睡前聽佛經小故事，可以放鬆心情，晚上睡眠時很少中途醒來。 3. 3/6個案可實際使用3種緩解焦慮的方法。 4. 3/7個案表示多虧護理師每日督促的持續復健，我現在又可以自行使用便盆椅了。 5. 3/7使用貝克焦慮量表評估焦慮程度，可由中度焦慮（23分）降低為輕度焦慮（11分）。 6. 3/9個案：「這一段時間很高興大家用心照顧我，我會繼續努力復健，不要讓家人擔心我」。 7. 3/15後續出院電訪追蹤，個案表示將於3/20號參加第一次重症肌無力病友會的活動。



討論及結論

本文描述一位重症肌無力病人之護理經驗，照護過程中確認個案有身體活動功能障礙、吞嚥困難及焦慮之健康問題，參考文獻建議，使用吞嚥技巧及肌力的訓練，但實際訓練能需依身體狀況調整復健內容，也勿過度訓練導致肌肉無力，個案想早日恢復日常生活功能，故後期有積極訓練，但過度易肌肉無力，仍需加強宣導疾病訓練的相關性。筆者訪談過程中發現到個案及案母，對於疾病的預後照護有知識上的限制，覺得按時服藥病情就不會有惡化情形，應與疾病認知程度有關聯，建議個案返家後加入重症肌無力病友會，找尋共同疾病的個案，可有利未來的照護及社交方面，限制上為個案雖有第一次的重症無力的經驗，但對於疾病認知度不佳，前期又因須仰賴他人產生的負面情緒，不願學習相關知識，但藥物及復健治療後肌力明顯改善，個案敞開心胸逐漸表達內心感受，可願意再度學習相關知識，後續本單位以將重症肌無力加入出院規畫高危險群收案條件，返家後持續電訪追蹤後續復健及復原狀況，個案出院後實際參與重症肌力病友會，將製作相關影片照護，讓一般民眾及相關個案更加認識，並了解重症肌無力症已不再被視為無法治療之重症，如何與疾病長期共存，是現在需面對的課題。

參考資料

吳佩珊、黃惠滿、林婉如（2015）・腦中風病患吞嚥障礙之評估與護理處置・*高雄護理雜誌，32*（3），91-98。https://doi.org/10.6692/kjn-2015-32-3-9

李秋香、張淑華、王素美、賴慶祥、賴美玉（2015）・音樂介入對使用呼吸器患者之焦慮成效探討－前驅性研究・*澄清醫護管理雜誌，11*（1），31-38。

車先蕙、盧孟良、陳錫中、張尚文、李宇宙（2006）・中文版貝克焦慮量表之信效度・*台灣醫學，10*（4），447-454。https://doi.org/10.6320/fjm.2006.10(4).05

林仲哲、林羿辰、李婕瑜、劉睿菁、顏向嬋、張玉君（2020）・吞嚥治療對不同年齡層腦中風吞嚥困難病人之療效探討・*台灣老年醫學暨老年學會雜誌，15*（4），271-282。https://doi.org/10.29461/TGGa.202011_15(4).0003

莊淑婷、葉建宏（2024）・重拾對未來的希望感：從肌無力症照護研究中反思溝通的意義・*諮商與輔導*，460，21-23。

陳玉黛、葉建宏、莊淑婷、邱浩彰（2016）・重症肌無力症病人生病歷程探討・*台灣醫學，20*（3），235-241。https://doi.org/10.6320/fjm.2016.20(3).1

程馨慧、董志明、蔡新茂、黃戊田（2014）・薰衣草精油與音樂療法對人體之紓壓成效薰衣草與音樂之紓壓・*美容科技學刊，11*（1），25-40。https://doi.org/10.30001/jies.201406_11(1).0002

楊荊生（2014）・非語言的影響力・*中華禮儀*，30，1-7。https://doi.org/10.29420/cfc.201406_(30).0001

楊舒媚、蕭名彥、王亭貴（2021）・重症肌無力症吞嚥障礙的處理・*台北市醫師公會會刊，65*（4），58-63。

楊嘉豪（2016）・腦中風物理治療・*血管醫學防治季刊*，26，5-6。https://doi.org/10.6527/pvm.2016.26.3

葉建宏、王圓晴（2024）・Myasthenia gravis（MG）同學有力向前行—肌無力症全人全程整合照護・*醫療品質雜誌，18*（3），56-59。https://doi.org/10.53106/199457952024051803011

鄭千惠、陳珮蓉（2020）・吞嚥困難與飲食食物質地標準・*台灣老年醫學暨老年學會雜誌，15*（2），73-83。https://doi.org/10.29461/TGGa.202005_15(2).0001

衛生福利部（2021，12月23日）・*全民健康保險重大傷病證明實際有效領證統計表*（2021年11月）。https://www.nhi.gov.tw/DL.aspx?sitessn=292&u=LzAwMS9VcGxvYWQvMjkyL3JlbGZpbGUvMC80NzE0LzExMDEx6YeN5aSn5YK355eFLnBkZg%3d%3d&n=MTEwMTHph43lpKflgrfnl4UucGRm&ico%20=.pdf

賴玉琪（2014）・重症肌無力・*嘉基藥訊*，114，1-3。

羅玉岱、陳乃菁、楊宜青（2020）・周全性老年評估個案報告：一位以衰弱為臨床表現之老年發病重症肌無力的婦女・*台灣老年醫學暨老年學會雜誌，15*（3），199-213。https://doi.org/10.29461/TGGa.202008_15(3).0004

Gilhus, N. E. (2021). Physical training and exercise in myasthenia gravis. *Neuromuscular Disorders*, *31*(3), 169-173. https://doi.org/10.1016/j.nmd.2020.12.004

Yew, K. S., & Cheng, E. M. (2015). Diagnosis of acute stroke. *American Family Physician*, *91*(8), 528-536.



Nursing experience in caring for a patient with myasthenia gravis

Yu-Jun Hung[1], Hui-Mei Chen[2*], Mei-Ling Huang[3]

This article describes the nursing experience with a case of recurrent myasthenia gravis, characterized by symptoms such as limb weakness and swallowing difficulties, as well as patient anxiety stemming from factors like an uncertain prognosis and quality of life concerns.. From March 1, 2022, to March 9, 2022, data were collected through physical assessments, observations, meetings, listening sessions, hands-on care, and medical record reviews. The Gordon's Functional Health Patterns assessment tool was utilized to identify issues including impaired physical activity, swallowing difficulties, and anxiety. Using a collaborative, interdisciplinary approach, an individualized rehabilitation plan was implemented to facilitate the patient's early return to self-care in daily life. Participation in a myasthenia gravis support group after discharge provided a sense of belonging and facilitated learning to cope with the disease. Additionally, educational videos on myasthenia gravis and follow-up phone calls were conducted to enhance disease awareness and adaptation among subsequent myasthenia gravis patients, aiming to guide future nursing care practices based on shared experiences.

Key Words: myasthenia gravis, dysphagia, physical activity impairment, anxiety

[1]RN, MSN, Department of Nursing, National Taiwan University Hospital Yunlin Branch

[2]HN, MSN, Department of Nursing, National Taiwan University Hospital Yunlin Branch

[3]MSN, RN, Vice Director, Department of Nursing, National Taiwan University Hospital Yunlin Branch

[*]Address correspondence to: Hui-Mei Chen, No.579, Sec. 2, Yunlin Rd., Douliu City, Yunlin County 640, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886(5)532-3911 ext. 567326 E-mail: Y02267@ms1.ylh.gov.tw